Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga

Rua Alberto Schmidt, 441 - Bairro: Centenário - CEP: 93800312 - Fone: 30985796 - Email: frsapirang2vciv@tjrs.jus.br

OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Nº 5002782-90.2021.8.21.0132/RS

REQUERENTE: DESIRE CABRAL SEVERO

REQUERIDO: DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

I - DOS FATOS:

DESIRE CABRAL SEVERO ajuizou *Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência* contra **DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA**., ambas qualificadas nos autos. Aduziu, em síntese, que foi diagnosticada com CID 10 C50.9 - Neoplasia maligna da mama, não especificada, necessitando de 6 sessões de quimioterapia com urgência, de modo que deve fazer uso dos seguintes medicamentos: DOCETAXEL, CABOPLANTINA AVC, TRANSTUZMABE E PERTUZUMABE. Afirmou que diante de tal situação, *"[...] procurou a ré para fazer o encaminhamento de pedido de autorização para o tratamento da quimioterapia, o qual foi aprovado, porém, para sua surpresa, a ré lhe informou que custearia penas 80% do tratamento, uma vez que, o contrato, na cláusula quarta, prevê o pagamento de coparticipação, na ordem de 20%, no máximo, para exames e tratamento. Nesse momento, a autora assustou-se e, por isso, procurou o médico responsável que lhe passou um orçamento de R$ 200.492,08, para o tratamento completo, ou seja, segundo a ré, teria que pagar R$ 40.098,41 a título de coparticipação, o que por óbvio, impossibilita o tratamento urgente, ressalvando que a autora é professora do Município e não dispõe de recursos para custear o tratamento. [...]*" (Págs. 2/3 da INIC1 - EVENTO 1). Discorreu sobre a abusividade da cobrança de coparticipação no valor estipulado. Relatou que faz jus aos danos morais *in re ipsa*, face a negativa da requerida. Requereu, liminarmente, que a ré proceda a cobertura integral da quimioterapia, de modo que forneça todo o medicamento que é necessário para o tratamento, bem como que seja determinando que se abstenha de cobrar coparticipação na ordem de 20% no tratamento quimioterápico a ser feito pela autora, que totalizam R$ 40.098,41. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 20.000,00. Pediu a AJG e juntou documentos (EVENTO 1).

Foi concedida a gratuidade da Justiça e indeferida a medida liminar (EVENTO 3), decisão que foi objeto de agravo de instrumento n. **5086214-64.2021.8.21.7000/TJRS** (EVENTO 7), que foi desprovido (EVENTO 24).

Citada (EVENTO 10 - 10/08/2021), a requerida apresentou contestação. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança de coparticipação. Sustentou a inexistência de abusividade quanto a forma de copartiicpação, bem como repeliu eventual onerosidade excessiva e ocorrência dos danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais e juntou documentos (EVENTO 22).

Houve réplica (EVENTO 15).

Após, ausente requerimento de outras provas (EVENTOS 21 e 22), vieram os autos conclusos para julgamento.

RELATEI.

DECIDO.

II - DOS FUNDAMENTOS:

Estando o feito regular e considerando que não se faz presente a necessidade de atividade probatória além da já realizada, passo ao julgamento da lide.

De início, é pertinente destacar que o Código de Defesa do Consumidor incide no feito, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2º e 3º do referido diploma.

Tal posicionamento, aliás, é respaldado pela Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, que apresenta o seguinte teor: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"*.

No caso dos autos, a parte autora postula a condenação da requerida ao custeio integral do tratamento quimioterápico (medicamentos: DOCETAXEL, CABOPLANTINA AVC, TRANSTUZMABE e ERTUZUMABE), sem coparticipação.

Os documentos juntados aos autos demonstra que a demandante é beneficiária do Plano de Saúde Coletivo Empresarial, possuindo como contratante o *"MUNICÍPIO DE SAPIRANGA"*, tudo conforme consta no Contrato (CONTR8 - EVENTO 1) - fato incontroverso.

A respeito da coparticipação, a Lei nº 9.656/98, que rege os planos e seguros provados de assistência à saúde, dispõe:

> *"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:*
>
> *(...)*
>
> *VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;"*

Sobre o tema, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, havendo previsão expressa no contrato, não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação - como é o caso dos autos, veja-se (Págs. 3/4 do CONTR8 - EVENTO 1):

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DA COPARTICIPAÇÃO, DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO REAJUSTE E DO ADITAMENTO

4.1 - A Contratada fica obrigada a praticar junto à Administração os valores unitários devidamente ajustados aos cotados na ocasião da apresentação da proposta/lance, no item em que foi declarada vencedora, quais sejam:

Faixa Etária	Total de Servidores Ativos	Total de Dependentes	Pensionistas	Aposentados	Ativos FAPS	Total Vidas	Valor Unitário R$
0 a 18	0	196	2	-	-	198	R$ 110,99
19 a 23	12	21	4	-	-	37	R$ 133,75
24 a 28	55	10	-	-	-	65	R$ 148,45
29 a 33	93	11	-	-	-	104	R$ 164,80
34 a 38	88	15	-	1	-	104	R$ 198,33
39 a 43	73	13	-	-	-	86	R$ 228,55
44 a 48	49	6	2	1	-	58	R$ 304,73
49 a 53	40	8	-	7	1	56	R$ 344,38
54 a 58	16	3	-	4	-	23	R$ 590,82
59 ou +	3	1	-	3	-	7	R$ 665,52
Total	**429**	**284**	**8**	**16**	**1**	**738**	

4.2 - Na tabela acima estão indicados os quantitativos estimados de servidores. Tais quantitativos não são garantias de faturamento, sendo que a Contratada deverá desenvolver campanhas internas junto aos servidores, oferecendo o respectivo plano de saúde para contratação. Sendo que tais contratações dependerão de ações da própria Contratada. (exemplo: campanhas de adesão junto aos servidores, preços atrativos perante os demais planos existentes no mercado,etc).

4.3 - Os beneficiários terão coparticipação financeira na realização de consultas, exames e procedimentos médicos cobertos pelo Plano de Saúde.

4.4 - As coparticipações dos usuários deverão atender no máximo a seguinte classificação:

- a) 20% - no máximo para exames e procedimentos.

4.5 - A coparticipação do usuário dos serviços por consulta realizada será de no máximo R$ 34,12 (trinta e quatro reais e doze centavos).

4.6 - O custo das despesas com coparticipações serão integralmente custeadas pelo usuário servidor e faturadas pela Prefeitura Municipal de Sapiranga.

4.7 - Não haverá coparticipação em internações hospitalares.

4.8 - Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93 e suas alterações, poderá ser concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

4.9 – No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses poderá ser concedido reajuste ao preço contratado, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como indexador o IGP-M/FGV POSITIVO acumulado daquele período.

4.10 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme previsão no art. 65, § 1° da Lei Federal nº. 8.666/93, respeitada a modalidade licitatória.

A questão é, inclusive, objeto do Tema Repetitivo 1032, que estabeleceu a seguinte tese:

> *"Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro".*

Destaco o seguinte trecho da decisão proferida no Recurso Especial nº 1.809.486 - SP (2019/0106488-1):

" (...) Em contratações como a ora em evidência, que tem por objeto a saúde e, em último grau, a manutenção da vida do indivíduo, a dignidade da pessoa humana desempenha papel fundamental e pode ser concretizada ou minimamente atendida mediante condutas de respeito ao aderente, de observância à função social do contrato e do estreito vínculo ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil e no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Inegavelmente, ao contratar um plano de saúde e despender mensalmente relevantes valores na sua manutenção, o consumidor busca garantir, por conta própria, acesso a um direito fundamental que, a rigor, deveria ser prestado pelo Estado de modo amplo, adequado, universal e irrestrito. Ocorre que, se a universalização da cobertura - apesar de garantida pelo constituinte originário no artigo 198 da Constituição Federal e considerada um dos princípios basilares das ações e serviços públicos de saúde nos termos do artigo 7º da Lei 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências - não é viabilizada pelo Estado no tempo e modo necessários para fazer frente às adversidades de saúde que acometem os cidadãos, tampouco pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos do artigo 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei 8.080/90, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. (grifo nosso)

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. (grifo nosso)

A presente discussão vincula-se, exatamente, às entidades privadas de assistência à saúde que, embora prestem – de modo secundário e supletivo - serviços de utilidade pública relacionados a direito fundamental estabelecido na Carta Constitucional, exercem, no âmbito do sistema da livre iniciativa, o seu mister com foco na obtenção de lucro inerente à atividade exercida, ressalvadas aquelas instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos.

Assim, diferentemente do Estado, que tem o dever de prestar assistência ampla e ilimitada à população, a iniciativa privada se obriga nos termos da legislação de regência e do contrato firmado entre as partes, no âmbito do qual são estabelecidos os serviços a serem prestados/cobertos, bem como as limitações e restrições de direitos.

A Lei nº 9.656/98 rege os planos e seguros privados de assistência à saúde e permite à operadora dos respectivos serviços custear, total ou parcialmente, a assistência médica, hospitalar e odontológica de seus clientes, estabelecendo no artigo 16, inciso VIII, que os contratos, regulamentos ou produtos colocados à disposição dos consumidores podem fixar "a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário":

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

Como se vê da lei de regência, os planos de saúde podem ser coparticipativos ou não, sendo, pois, lícita a incidência da coparticipação em determinadas despesas, desde que informado com clareza o percentual deste compartilhamento, nos termos dos artigos 6º, inciso III e 54, §§ 3º e 4º da Lei 8.078/90, nos quais estabelecido que eventuais limitações a direitos, ressalvas e restrições de cobertura, bem como estipulações e obrigações carreadas aos consumidores devem ser redigidos de modo claro, com caracteres ostensivos e legíveis e com o devido destaque a fim de permitir a fácil compreensão pelo consumidor.

(...)

A toda evidência, consoante os ditames legais e regulamentares acerca da questão jurídica, verifica-se que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor, limitada ao máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrente de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos privados de saúde (...)".

Na mesma linha a Corte Superior decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. ***Segundo a jurisprudência desta Corte, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro (REsp 1809486/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020).*** *2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido daausência de previsão contratual do regime de coparticipação do segurado,fundamenta-se nas particularidades do contrato e do contexto fático-probatório que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.*

(AgInt no AREsp n. 1.874.119/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.328.093/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO APÓS O 30º DIA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA QUANTO AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO. TEMA 1032 DO STJ. 1. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da lei 9.656/98. Súmula n. 608 do STJ. 2. Nos termos do atual posicionamento jurídico do STJ, a cláusula contratual que prevê a coparticipação do beneficiário não se afigura ilícita, ainda que prevista em percentual sobre o custo do tratamento, desde que contratada de forma clara e expressa e não seja abusiva. 3. ***Aplicável ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 1032 do STJ, que prevê que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 4. No caso dos autos, inexiste abusividade na cobrança pela ré de coparticipação de 50% após os primeiros 30 dias de internação, porquanto a medida visa uma diminuição do custo do seguro ou plano de saúde, bem como priorizar outras formas de tratamento para casos de ordem mental, de modo que o afastamento da cláusula implicaria em modificação do contrato sem a devida contraprestação por parte do consumidor.*** *Precedentes do STJ e desta Corte. Dado provimento ao apelo da parte ré. (Apelação Cível, Nº 70083697276, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 30-03-2022)*

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE SUPLEMENTAR. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. TEMA 1032. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1032, firmou a tese no seguinte sentido: "Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro." ***No caso, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação em internações psiquiátricas nos períodos que ultrapassarem 30 dias, no percentual de 50% por dia de internação, de modo que não há qualquer abusividade praticada pela operadora de saúde****. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (Apelação Cível, Nº 50248528220168210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 22-02-2022)*

Diante deste contexto, não há falar em abusividade da referida cobrança, uma vez que encontra amparo legal e previsão expressa no contrato entabulado entre as partes, bem como respaldo da jurisprudência atual do STJ.

Outrossim, gizo que diante a ausência de ato ilícito, nos termos da fundamentação supra, não há falar em indenização por danos morais.

Dessarte, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva, inclusive a repetição do indébito, pois não demonstrado ato ilícito praticado pela requerida.

Ao desfecho, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado pelas partes.

III – DO DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com base no art. 487, inc. I, do CPC/15, **julgo IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por DESIRE CABRAL SEVERO contra DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA.

Condeno a parte autora ao pagamento da taxa judiciária e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, estes acrescidos de correção monetária pelo IGPM a partir do respectivo ajuizamento [09/06/2021] e juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, considerada a natureza da demanda, bem como o tempo de tramitação do processo, forte art. 85, § 2º, do CPC/15; suspensa a exigibilidade ante a AJG anteriormente concedida, EVENTO 3.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Havendo recurso(s) – **excepcionados embargos de declaração** – intime(m)-se, independentemente de conclusão (ato ordinatório – arts. 152, VI, CPC/15, e 567, XX, da Consolidação Normativa Judicial), a(s) contraparte(s) para contrarrazões, remetendo-se em seguida os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1010 § 3º, CPC/15).

Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões e após o Ministério Público (se for o caso de intervenção), remetendo-se em seguida os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1010 § 3º, CPC/15).

Com a preclusão, ressalvadas eventuais custas/despesas processuais pendentes, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO PRECI, Juiz Substituto**, em 3/2/2023, às 12:47:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10032323426v20** e o código CRC **96243b7e**.